

B01

Não matarás

BASE MORAL

CASO

Um hospital discute um protocolo para aplicar uma dose letal em pacientes terminais que assinem um formulário, alegando que isso reduziria sofrimento e conflitos familiares.

LEITURA DO CASO

- 1 **Ato direto:** A dose letal não é tratamento do sofrimento, mas ação ordenada a provocar a morte.
- 2 **Limite moral:** O quinto mandamento protege a vida inocente também quando ela está frágil, terminal ou dependente.
- 3 **Resposta cristã:** A fé manda aliviar e acompanhar, não transformar a morte em procedimento.

CONFERÊNCIA

Por que o mandamento não matará continua valendo quando a intenção declarada é aliviar sofrimento?

NOTA

Mostre que a compaixão não autoriza matar uma vida inocente.

Ex 20,13 · CEC 2277

B02

Imagem de Deus

BASE MORAL

CASO

Uma mulher com demência avançada já não reconhece os filhos, e alguém comenta que ela deixou de ser a pessoa que era.

LEITURA DO CASO

- 1 **Capacidade perdida:** A demência tira memória e autonomia, mas não tira a identidade pessoal diante de Deus.
- 2 **Critério cristão:** A dignidade vem do ser pessoa criada por Deus, não do desempenho mental.
- 3 **Cuidado devido:** Justamente por estar mais vulnerável, ela precisa de mais proteção e presença.

CONFERÊNCIA

O que muda quando a dignidade da pessoa é fundada na imagem de Deus, e não na memória ou na lucidez?

NOTA

Evite romantizar a doença; afirme que a perda de capacidades não apaga a pessoa.

Gn 1,27 · CEC 1700

B03

Vida como dom

BASE MORAL

CASO

Depois de receber um diagnóstico grave, um homem diz que sua vida é só dele e que ninguém pode questionar seu plano de pedir a morte assistida.

LEITURA DO CASO

- 1 **Ferida real:** O diagnóstico pode trazer medo, revolta e sensação de perda de controle.
- 2 **Dom recebido:** A vida não é objeto que o indivíduo possui sem referência a Deus e aos outros.
- 3 **Responsabilidade:** A resposta cristã busca cuidado, decisão prudente e entrega da vida ao Senhor.

CONFERÊNCIA

Como distinguir respeito pela história de alguém da ideia de que a vida é uma posse absoluta?

NOTA

Reconheça a dor real, mas corrija a noção de posse total da vida.

Rm 14,7-8 · 1Cor 6,19-20

B04

Criador e Senhor

BASE MORAL

CASO

Uma comissão hospitalar debate se certos pacientes inconscientes deveriam ser removidos dos cuidados básicos para liberar leitos mais rapidamente.

LEITURA DO CASO

- 1 **Pressão institucional:** A falta de leitos cria decisões difíceis, mas não concede poder para eliminar pessoas.
- 2 **Senhor da vida:** A vida humana pertence primeiramente a Deus, Criador e Senhor.
- 3 **Limite da decisão:** Administrar recursos não pode virar autorização para provocar a morte.

CONFERÊNCIA

Por que nenhuma autoridade humana pode decidir que uma vida inocente perdeu o direito de existir?

NOTA

Diferencie gestão difícil de poder indevido sobre a vida.

CEC 2277 · Rm 14,7-8

B05

Dignidade do enfermo

BASE MORAL

CASO

Um paciente terminal começa a ser tratado no quarto como se estivesse ausente: falam de custos, horários e herança sem perguntar nada a ele.

LEITURA DO CASO

- 1 **Presença ignorada:** O paciente é tratado como problema administrativo, não como pessoa presente.
- 2 **Respeito especial:** A enfermidade exige consideração maior, não invisibilidade.
- 3 **Olhar de Cristo:** Visitar o enfermo inclui reconhecê-lo, ouvi-lo e cuidar dele com respeito.

CONFERÊNCIA

Que sinais mostram que a dignidade do enfermo está sendo ferida mesmo sem agressão física?

NOTA

A dignidade se manifesta também no modo de falar e decidir perto do doente.

CEC 2276 · Mt 25,36

B06

Pessoa até o fim

BASE MORAL

CASO

Após meses de coma, uma família passa a chamar o paciente apenas de corpo, e as decisões começam a ser tomadas como se ele já não fosse alguém.

LEITURA DO CASO

- 1 **Linguagem redutora:** Chamar alguém de corpo facilita esquecer sua dignidade pessoal.
- 2 **Pessoa permanece:** Consciência reduzida ou ausente não transforma o ser humano em coisa.
- 3 **Decisão moral:** O cuidado deve considerar a condição clínica sem apagar quem é cuidado.

CONFERÊNCIA

Como a fé cristã ajuda a distinguir estado clínico grave de perda da condição de pessoa?

NOTA

Não negue a gravidade do coma; afirme a permanência da pessoa.

CEC 2276 · B02

B07

Respeito especial

BASE MORAL

CASO

Em uma instituição de longa permanência, os residentes mais dependentes são os últimos a receber banho, troca e visitas médicas porque reclamam menos.

LEITURA DO CASO

- 1 **Vulnerabilidade explorada:** Quem tem menos voz acaba recebendo menos atenção.
- 2 **Exigência moral:** O Catecismo ensina que vidas diminuídas ou enfraquecidas pedem respeito especial.
- 3 **Cuidado concreto:** Proteger o frágil exige rotina, prioridade e responsabilidade verificável.

CONFERÊNCIA

Por que a vulnerabilidade aumenta a responsabilidade dos cuidadores, em vez de diminuir o dever de cuidado?

NOTA

Mostre que dependência não reduz direitos; ela pede proteção mais cuidadosa.

CEC 2276 · Mt 25,36

B08

Eutanásia direta

BASE MORAL

CASO

Uma clínica oferece um pacote para pacientes incuráveis: consulta, assinatura e aplicação de medicamento destinado a causar a morte.

LEITURA DO CASO

- 1 **Meio usado:** O medicamento é escolhido para causar a morte, não para tratar um sintoma.
- 2 **Finalidade declarada:** A morte é o meio planejado para suprimir sofrimento.
- 3 **Juízo moral:** A Igreja chama esse ato de moralmente inadmissível e gravemente contrário à dignidade humana.

CONFERÊNCIA

Quais elementos mostram que esse caso é eutanásia direta, e não cuidado paliativo?

NOTA

Peça que identifiquem ação, intenção e finalidade.

CEC 2277 · Ex 20,13

B09

Intenção de matar

BASE MORAL

CASO

Um médico diz que a medicação vai resolver o sofrimento porque o paciente não acordará mais, e ajusta a dose para garantir que ele morra naquela noite.

LEITURA DO CASO

- 1 **Objetivo escondido:** A fala usa linguagem de alívio, mas a dose é ajustada para produzir morte.
- 2 **Critério decisivo:** Quando a morte é querida como fim ou meio, entra-se no campo da eutanásia.
- 3 **Cuidado legítimo:** Aliviar dor é bom quando a morte não é desejada, apenas tolerada como risco inevitável.

CONFERÊNCIA

Por que a intenção muda a leitura moral do uso de uma medicação no fim da vida?

NOTA

Destaque que o mesmo tipo de recurso pode ter sentido moral diferente conforme intenção, meio e proporção.

CEC 2277 - G02

B10

Caridade que cuida

BASE MORAL

CASO

Uma equipe de enfermagem sabe que o paciente não terá cura, mas organiza banho, controle de dor, conversa breve e contato com a família todos os dias.

LEITURA DO CASO

- 1 **Sem cura esperada:** A equipe sabe que não vencerá a morte naquele caso.
- 2 **Cuidado real:** Mesmo assim, alivia, limpa, escuta e aproxima a família.
- 3 **Caridade cristã:** Cuidar permanece obrigatório quando curar já não é possível.

CONFERÊNCIA

Como esse cuidado mostra que a caridade cristã não depende de promessa de cura?

NOTA

Valorize a caridade concreta sem transformar a cena em idealização perfeita.

Mt 25,36 - CEC 2279

B11

Visita ao doente

BASE MORAL

CASO

Um senhor internado há semanas recebe alta possibilidade de morte, mas os parentes evitam ir ao hospital porque não sabem o que dizer.

LEITURA DO CASO

- 1 **Medo da presença:** A família foge porque a doença e a morte deixam todos sem palavras.
- 2 **Encontro concreto:** Cristo se identifica com o enfermo visitado.
- 3 **Caridade possível:** Uma presença simples pode combater abandono e desespero.

CONFERÊNCIA

Por que visitar o doente pode ser uma resposta cristã mesmo quando ninguém consegue resolver a doença?

NOTA

Mostre que presença humilde é cuidado, não simples gesto social.

Mt 25,36 - CEC 1503

B12

Cuidados devidos

BASE MORAL

CASO

Como o paciente está em fase final, alguém propõe suspender banho, troca de curativos e hidratação que ainda o ajuda, para não gastar energia com quem vai morrer.

LEITURA DO CASO

- 1 **Abandono prático:** O argumento usa a proximidade da morte para cortar cuidados básicos.
- 2 **Dever permanece:** O Catecismo afirma que cuidados comumente devidos não podem ser legitimamente interrompidos.
- 3 **Proporção:** Alimentação e hidratação devem ser avaliadas conforme benefício e possibilidade, sem intenção de matar.

CONFERÊNCIA

Como distinguir cuidados comumente devidos de tratamentos que podem ser legitimamente interrompidos?

NOTA

Evite regra simplista; use a noção de cuidado proporcionado e benéfico.

CEC 2279 - G14

B13

Esperança cristã

BASE MORAL

CASO

Uma mulher em tratamento paliativo diz que Deus a abandonou porque a cura não veio, e a família evita tocar no assunto.

LEITURA DO CASO

- 1 **Crise espiritual:** A falta de cura pode ser vivida como abandono de Deus.
- 2 **Esperança real:** A esperança cristã não exige negar a gravidade da doença.
- 3 **Graça no limite:** A fé sustenta a pessoa para ser acompanhada e entregue a Deus com confiança.

CONFERÊNCIA

Como a esperança cristã evita tanto negar a morte quanto concluir que o sofrimento prova ausência de Deus?

NOTA

Não prometa cura; fale de presença de Deus, graça e acompanhamento.

2Cor 12,9 - CEC 1520

B14

Consciência formada

BASE MORAL

CASO

Antes de decidir sobre um tratamento, uma família se informa apenas por vídeos emocionais nas redes e por uma opinião apressada no grupo de mensagens.

LEITURA DO CASO

- 1 **Informação frágil:** A família se orienta por emoção e conteúdo sem critério.
- 2 **Consciência reta:** A consciência deve ser formada pela verdade, pela moral e por informações confiáveis.
- 3 **Decisão prudente:** Diante da morte, é preciso escutar profissionais, doutrina e pessoas legitimamente responsáveis.

CONFERÊNCIA

Por que uma decisão grave sobre vida e morte exige consciência formada, e não apenas emoção ou opinião circulante?

NOTA

Mostre que consciência não é palpite pessoal; precisa buscar verdade e bem.

CEC 1776 - CEC 1783

B15

Sofrimento acompanhado

BASE MORAL

CASO

Um paciente com câncer avançado suporta dores, medo e vergonha da dependência; quando alguém fica ao lado dele sem discursos, ele começa a aceitar ajuda.

LEITURA DO CASO

- 1 **Sofrimento concreto:** A dor envolve corpo, medo, vergonha e dependência.
- 2 **Sem romantização:** A fé não chama a dor de coisa boa em si, nem a usa para abandonar tratamento.
- 3 **Acompanhamento:** A resposta cristã alivia, permanece e ajuda a viver o limite diante de Deus.

CONFERÊNCIA

Como acompanhar o sofrimento sem romantizá-lo nem transformá-lo em motivo para matar?

NOTA

Una firmeza moral e realismo sobre a dor.

CEC 2279 - 2Cor 12,9

I01

Pedido de morte

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Uma senhora com dor e falta de ar diz à filha: eu queria dormir e não acordar mais.

LEITURA DO CASO

- 1 **Pedido ambíguo:** A frase pode expressar sofrimento extremo, não uma decisão moral clara e estável.
- 2 **Risco moral:** Responder com morte provocada troca escuta por eliminação.
- 3 **Caminho cristão:** É preciso investigar dor, medo e abandono, oferecendo cuidado real.

CONFERÊNCIA

Que perguntas e cuidados ajudam a escutar esse pedido sem tratá-lo automaticamente como escolha livre pela morte?

NOTA

O pedido pode esconder dor, medo, depressão ou solidão; não deve ser desprezado nem executado.

CEC 2277 - G11

I02

Dor sem controle

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Um paciente passa noites gritando de dor enquanto a equipe demora a revisar a medicação, e a família começa a falar em acabar logo com isso.

LEITURA DO CASO

- 1 **Dor negligenciada:** A falta de controle adequado torna o sofrimento quase insuportável.
- 2 **Desvio perigoso:** Quando a dor é abandonada, a morte pode parecer solução.
- 3 **Cuidado devido:** A resposta correta é analgesia proporcional e acompanhamento paliativo.

CONFERÊNCIA

Por que dor mal cuidada pode empurrar pessoas para uma conclusão moral errada?

NOTA

Afirme que controlar dor é dever sério, não detalhe secundário.

CEC 2279 - Q01

I03

Tratamento fútil

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Um paciente terminal é submetido a exames invasivos e transferências exaustivas, embora os médicos digam que nada mudará o desfecho.

LEITURA DO CASO

- 1 **Intervenção pesada:** Os procedimentos cansam o paciente sem oferecer benefício razoável.
- 2 **Futilidade:** Nem tudo que a técnica permite deve ser moralmente imposto.
- 3 **Aceitação legítima:** Pode ser correto recusar obstinação e manter cuidados proporcionados.

CONFERÊNCIA

Que critério ajuda a perceber quando um tratamento deixa de servir ao bem do paciente?

NOTA

Mostre que recusar futilidade não é desejar a morte.

CEC 2278 - G05

I04

UTI sem benefício

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Uma mulher muito idosa permanece entubada na UTI, sem chance razoável de recuperação, enquanto a família teme que retirar o suporte seja matar.

LEITURA DO CASO

- 1 **Medo compreensível:** A família associa retirar suporte a abandono ou culpa.
- 2 **Obstinação possível:** A UTI pode se tornar desproporcional quando só prolonga o processo de morrer.
- 3 **Cuidado mantido:** Recusar obstinação exige manter conforto, presença e cuidados devidos.

CONFERÊNCIA

Como distinguir retirar suporte desproporcional de provocar a morte?

NOTA

Aponte a diferença entre aceitar a limitação da medicina e causar morte intencionalmente.

CEC 2278 - G07

I05

Sedação no fim

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Com dor refratária e falta de ar intensa, um paciente recebe sedação proporcional; a família teme que isso seja eutanásia.

LEITURA DO CASO

- 1 **Sofrimento extremo:** A sedação busca aliviar sintomas intoleráveis no fim da vida.
- 2 **Intenção moral:** Não se deseja a morte como fim nem como meio, ainda que um risco seja previsto.
- 3 **Cuidado paliativo:** Quando proporcional, esse alívio pode estar conforme à dignidade humana.

CONFERÊNCIA

Quais critérios distinguem sedação moralmente lícita de eutanásia?

NOTA

Trabalhe intenção, proporcionalidade e efeito previsto.

CEC 2279 - G06

I06

Alimentação suspensa

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Uma paciente ainda assimila água e nutrição simples, mas alguém propõe suspender tudo porque ela não conversa mais.

LEITURA DO CASO

- 1 **Critério errado:** A proposta se baseia na ausência de conversa, não na proporção clínica do cuidado.
- 2 **Cuidado devido:** Cuidados comuns não podem ser interrompidos só porque a pessoa está dependente.
- 3 **Discernimento:** É preciso avaliar benefício, possibilidade e intenção, sem buscar a morte.

CONFERÊNCIA

Por que a falta de comunicação não basta para retirar cuidados básicos proporcionados?

NOTA

Não transforme alimentação e hidratação em regra mecânica; destaque proporção e intenção.

CEC 2279 - G14

I07

Idoso pressionado

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Um idoso ouve repetidas conversas sobre despesas, trabalho perdido e cansaço dos filhos; dias depois, diz que talvez fosse melhor não estar mais vivo.

LEITURA DO CASO

- 1 **Pressão silenciosa:** O idoso absorve a ideia de que sua existência pesa demais.
- 2 **Liberdade ferida:** Uma escolha feita para não incomodar pode nascer de abandono e culpa induzida.
- 3 **Proteção:** A resposta cristã afirma valor, oferece ajuda e impede decisões sob pressão.

CONFERÊNCIA

Como a pressão indireta pode deformar a liberdade de um idoso doente?

NOTA

Mostre que nem toda pressão aparece como ameaça direta.

CEC 2276 - N03

I08

Coma prolongado

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Depois de um acidente, um homem permanece em coma; conhecidos perguntam por que a família ainda gasta tempo com alguém que não percebe nada.

LEITURA DO CASO

- 1 **Consciência ausente:** O coma impede comunicação e resposta visível.
- 2 **Valor intacto:** A pessoa não perde dignidade porque não consegue demonstrar consciência.
- 3 **Cuidado fiel:** A família deve discernir tratamentos proporcionais sem abandonar a pessoa.

CONFERÊNCIA

Que erro aparece quando o valor da pessoa é medido pela consciência visível?

NOTA

Evite prometer recuperação; a questão é dignidade, não prognóstico.

B06 - CEC 2276

I09

Deficiência grave

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Durante uma discussão pública, alguém afirma que certas deficiências graves tornam a vida indigna de ser vivida.

LEITURA DO CASO

- 1 **Juízo sobre valor:** A frase decide que algumas vidas valem menos por causa de sua condição.
- 2 **Erro antropológico:** Deficiência não reduz humanidade nem dignidade.
- 3 **Dever social:** A resposta é amparo real, inclusão possível e cuidado proporcionado.

CONFERÊNCIA

Por que essa frase atinge a dignidade da pessoa, e não apenas uma opinião sobre sofrimento?

NOTA

Corrija a ideia sem negar que algumas condições exigem cuidado intenso.

B02 - CEC 2276

I10

Família exausta

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Depois de meses revezando noites, uma família cansada começa a discutir decisões graves em tom de irritação e culpa.

LEITURA DO CASO

- 1 **Cansaço real:** Cuidar por muito tempo desgasta corpo, emoções e relações familiares.
- 2 **Critério insuficiente:** Exaustão explica fragilidade, mas não autoriza decisão injusta sobre a vida.
- 3 **Ajuda necessária:** A resposta prudente inclui revezamento, orientação, descanso e apoio externo.

CONFERÊNCIA

Como reconhecer o cansaço dos cuidadores sem deixá-lo virar critério para eliminar o doente?

NOTA

Valide o esgotamento real, mas não o transforme em norma moral.

G15 · O09

I11

Médico pressionado

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Um médico de plantão é chamado por familiares que pedem uma medicação forte para encerrar o sofrimento de modo definitivo.

LEITURA DO CASO

- 1 **Pedido grave:** A família quer uma ação médica que produza morte.
- 2 **Consciência profissional:** O médico não pode transformar sua competência em instrumento de eliminação.
- 3 **Alternativa ética:** Ele deve propor controle de sintomas, paliativos e decisão proporcional.

CONFERÊNCIA

Que responsabilidade moral o profissional tem quando a pressão vem revestida de compaixão?

NOTA

Destaque consciência profissional e dever de cuidar sem matar.

B14 · O15

I12

Herança apressada

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Antes mesmo de uma decisão clínica clara, parentes começam a calcular venda de imóvel e pressionam para que o tratamento não continue.

LEITURA DO CASO

- 1 **Interesse oculto:** A herança entra no centro antes da avaliação do bem do doente.
- 2 **Vulnerável em risco:** Quem não consegue se defender pode virar obstáculo econômico.
- 3 **Decisão limpa:** É preciso separar patrimônio, cansaço e cuidado proporcional.

CONFERÊNCIA

Como interesses econômicos podem contaminar uma decisão que deveria buscar o bem do paciente?

NOTA

Não acuse toda família em conflito; mostre o risco moral concreto.

N06 · B07

I13

Seguro nega cuidado

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Um plano de saúde nega tratamento de dor e oferece apenas alta rápida, deixando a família sem orientação e sem suporte domiciliar.

LEITURA DO CASO

- 1 **Cuidado bloqueado:** A burocracia impede alívio e acompanhamento necessários.
- 2 **Pressão econômica:** Quando o cuidado desaparece, a morte pode parecer saída prática.
- 3 **Resposta justa:** É legítimo buscar recursos, reclamar formalmente e proteger o paciente.

CONFERÊNCIA

Por que negar cuidado proporcional pode empurrar uma família para escolhas moralmente perigosas?

NOTA

Aponte a dimensão institucional sem transformar a carta em debate partidário.

N06 · O14

I14

Solidão hospitalar

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Um paciente internado há semanas recebe procedimentos corretos, mas quase nenhuma visita; quando a noite chega, ele pede para não continuar.

LEITURA DO CASO

- 1 **Tratamento sem vínculo:** Os procedimentos existem, mas a pessoa se sente sozinha e esquecida.
- 2 **Sofrimento ampliado:** A solidão torna a doença mais pesada e enfraquece a esperança.
- 3 **Presença cristã:** Visitar, telefonar e permanecer são formas concretas de cuidado.

CONFERÊNCIA

Como a solidão pode agravar o sofrimento e influenciar pedidos de morte?

NOTA

Mostre que cuidado técnico sem presença pode ficar moralmente incompleto.

Mt 25,36 · O12

I15

Documento ambíguo

SITUAÇÕES CONCRETAS

CASO

Um documento de vontade antecipada diz que a paciente não quer máquinas inúteis, mas também pede qualquer medida que apresse a morte se houver sofrimento.

LEITURA DO CASO

- 1 **Mistura de pedidos:** O documento une uma recusa legítima e uma intenção moralmente errada.
- 2 **Critério:** Não querer obstinação é diferente de pedir que alguém provoque a morte.
- 3 **Registro prudente:** A vontade razoável deve favorecer cuidados proporcionais e excluir eutanásia.

CONFERÊNCIA

Como separar recusa legítima de tratamento desproporcional de pedido inadmissível de morte provocada?

NOTA

Use a carta para treinar distinção, não para rejeitar todo registro antecipado.

CEC 2278 · B08

N01

Falsa compaixão

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Um filho diz que não aguenta ver a mãe sofrer e conclui que o gesto mais compassivo seria pedir uma injeção para ela morrer.

LEITURA DO CASO

- 1 **Compaixão ferida:** O sofrimento de quem ama pode gerar desejo de acabar com a cena dolorosa.
- 2 **Desvio moral:** Eliminar a mãe não é aliviar a dor dela com meios proporcionais.
- 3 **Caridade correta:** A compaixão cristã cuida, trata a dor e permanece junto.

CONFERÊNCIA

Como distinguir compaixão verdadeira de uma resposta que elimina a pessoa sofredora?

NOTA

Reconheça a dor do filho, mas mostre o desvio moral da solução.

CEC 2277 · CEC 2279

N02

Falsa dignidade

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Em uma reportagem, a expressão morrer com dignidade aparece sempre ligada ao direito de receber ajuda para morrer, e nunca ao direito de ser cuidado até o fim.

LEITURA DO CASO

- 1 **Palavra deslocada:** Dignidade é usada para justificar a morte provocada.
- 2 **Sentido cristão:** Dignidade não depende de autonomia plena nem desaparece no sofrimento.
- 3 **Morrer bem:** Morrer com dignidade significa ser cuidado, acompanhado e respeitado até o fim.

CONFERÊNCIA

Que sentido cristão de dignidade corrige essa maneira de usar a expressão morrer com dignidade?

NOTA

Não descarte a expressão; recupere seu sentido verdadeiro.

B05 · CEC 2276

N03

Mentira de ser peso

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Uma senhora pede desculpas toda vez que precisa ser levantada da cama e começa a dizer que a família ficaria melhor sem ela.

LEITURA DO CASO

- 1 **Culpa absorvida:** A dependência faz a pessoa interpretar sua vida como incômodo.
- 2 **Mentira moral:** Dar trabalho não reduz a dignidade nem autoriza desejar a própria eliminação.
- 3 **Resposta concreta:** A família deve afirmar valor e buscar revezamento para não transformar cuidado em acusação.

CONFERÊNCIA

Como responder a quem se vê apenas como peso sem negar as dificuldades reais do cuidado?

NOTA

Uma verdade e concretude: afirmar valor e organizar ajuda.

B02 - I07

N04

Vida sem utilidade

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Um comentarista defende que manter vivos pacientes que não produzem nem decidem sozinhos é desperdício de recursos humanos.

LEITURA DO CASO

- 1 **Cálculo utilitário:** A fala mede a pessoa pelo que ela produz ou economiza.
- 2 **Erro de fundamento:** A dignidade humana não nasce da utilidade social.
- 3 **Proteção do fraco:** A fé protege justamente quem não consegue provar valor por desempenho.

CONFERÊNCIA

Por que medir a vida pela utilidade é incompatível com a visão cristã da pessoa?

NOTA

Mostre o risco de transformar pessoas em cálculo de rendimento.

B06 - CEC 1700

N05

Autonomia absoluta

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Uma paciente lúcida afirma que, se pode decidir onde mora e como trata seus bens, também deve poder exigir que alguém provoque sua morte.

LEITURA DO CASO

- 1 **Liberdade ampliada:** A paciente compara decisões comuns com uma decisão sobre provocar morte.
- 2 **Limite moral:** Nem tudo que alguém deseja pode se tornar dever de outro executar.
- 3 **Vida recebida:** A vida é dom confiado por Deus e não posse absoluta.

CONFERÊNCIA

Qual é o limite moral da autonomia quando a decisão envolve tirar uma vida inocente?

NOTA

Explique que liberdade real não é poder ilimitado sobre o bem e o mal.

B03 - Rm 14,7-8

N06

Custo decide a vida

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Em uma reunião administrativa, alguém defende que pacientes muito caros deveriam ter uma via mais rápida para encerrar a vida.

LEITURA DO CASO

- 1 **Cálculo perigoso:** O custo passa a ocupar o lugar da dignidade da pessoa.
- 2 **Vulneráveis ameaçados:** Quem mais precisa de cuidado se torna o primeiro descartável.
- 3 **Justiça no cuidado:** Recursos devem ser administrados sem transformar morte em economia.

CONFERÊNCIA

Por que o custo do cuidado não pode ser o critério que decide se alguém deve viver?

NOTA

Evite negar limites econômicos; negue que economia tenha poder de eliminar vidas.

B07 - I13

N07

Dor sem sentido

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Ao ver um paciente sofrer, um parente diz que nenhuma vida com tanta dor pode ter sentido.

LEITURA DO CASO

- 1 **Dor esmagadora:** A dor intensa pode parecer maior do que qualquer esperança.
- 2 **Conclusão falsa:** Sofrimento não prova que a vida perdeu valor.
- 3 **Cuidado devido:** É preciso aliviar a dor e acompanhar a pessoa, não decretar inutilidade da vida.

CONFERÊNCIA

Como afirmar sentido e dignidade sem fingir que a dor não é grave?

NOTA

Fuja de respostas fáceis; a dor deve ser tratada seriamente.

B15 - CEC 2279

N08

Morte como cuidado

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Uma campanha pública apresenta a eutanásia como nova modalidade de cuidado de fim de vida, sem mencionar a intenção de causar a morte.

LEITURA DO CASO

- 1 **Vocabulário suave:** A campanha usa linguagem de cuidado para encobrir a morte provocada.
- 2 **Diferença moral:** Cuidar é aliviar e acompanhar; eutanásia é provocar morte para suprimir sofrimento.
- 3 **Verdade necessária:** A caridade precisa de linguagem clara para não chamar mal de bem.

CONFERÊNCIA

Por que a linguagem de cuidado pode esconder uma diferença moral decisiva?

NOTA

Ensine a ler palavras bonitas com critério moral.

B08 - G06

N09

Progresso que elimina

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Um debate televisivo chama a eutanásia de sinal de país moderno, tratando toda objeção moral como atraso religioso.

LEITURA DO CASO

- 1 **Rótulo sedutor:** A palavra moderno tenta encerrar a discussão antes do discernimento.
- 2 **Crítério cristão:** Uma sociedade não progride quando facilita eliminar os frágeis.
- 3 **Vulnerabilidade:** A verdadeira civilização protege quem sofre, não oferece morte como saída.

CONFERÊNCIA

Como avaliar uma proposta chamada de moderna sem aceitar automaticamente que ela seja justa?

NOTA

Não entre em disputa partidária; foque no critério moral da vida vulnerável.

B07 - CEC 2277

N10

Legal então moral

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Após ouvir que a eutanásia é permitida em outro país, alguém conclui que a Igreja deveria aceitar porque a lei já resolveu a questão.

LEITURA DO CASO

- 1 **Lei invocada:** A legalização é usada como prova automática de moralidade.
- 2 **Moral permanece:** A lei civil pode permitir algo que continua gravemente errado diante de Deus.
- 3 **Consciência formada:** A consciência cristã não terceiriza o bem e o mal ao consenso jurídico.

CONFERÊNCIA

Por que uma permissão legal não basta para definir a bondade moral de um ato?

NOTA

Explique com serenidade a diferença entre ordem civil e lei moral.

Ex 20,13 - B14

N11

Só antecipar o fim

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Um familiar afirma que não há problema em provocar a morte porque os médicos já disseram que a paciente morrerá em poucos dias.

LEITURA DO CASO

- 1 **Minimização:** A frase reduz a gravidade do ato porque a morte está próxima.
- 2 **Ato distinto:** Provocar a morte não é o mesmo que aceitar que ela não pode ser impedida.
- 3 **Cuidado até o fim:** Mesmo nos últimos dias, permanece o dever de aliviar e acompanhar.

CONFERÊNCIA

Por que a proximidade da morte não transforma matar em ato moralmente neutro?

NOTA

Trabalhe a diferença entre morte inevitável e morte provocada.

CEC 2277 - G14

N12

Amor que elimina

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Um marido diz que ama demais a esposa para deixá-la viver a fase final da doença, e por isso quer que tudo termine logo.

LEITURA DO CASO

- 1 **Amor ferido:** O marido sofre ao ver a esposa sofrer.
- 2 **Objeto errado:** A solução proposta elimina a esposa junto com a dor.
- 3 **Amor verdadeiro:** A caridade permanece, alivia e protege sem provocar a morte.

CONFERÊNCIA

Como o amor pode ser desordenado quando tenta eliminar a pessoa para eliminar a dor?

NOTA

Reconheça o amor real, mas mostre que amor precisa ser purificado pela verdade.

B10 - Mt 25,36

N13

Invisibilidade cômoda

NARRATIVAS FALSAS

CASO

No prédio, quase ninguém visita uma moradora acamada; muitos defendem sua decisão de morrer, mas não oferecem companhia, comida ou ajuda.

LEITURA DO CASO

- 1 **Ausência coletiva:** A vizinhança fala sobre a morte, mas não se aproxima da vida sofrida.
- 2 **Conforto dos outros:** A invisibilidade do doente torna mais fácil aceitar sua eliminação.
- 3 **Visita necessária:** A resposta cristã rompe isolamento com presença concreta e responsável.

CONFERÊNCIA

Como a omissão cotidiana pode tornar a eutanásia socialmente mais aceitável?

NOTA

Mostre que abandono prepara o terreno para falsas soluções.

B11 - I14

N14

Cansaço como critério

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Uma cuidadora familiar, sem dormir direito há meses, diz que qualquer saída é válida porque ninguém aguenta mais.

LEITURA DO CASO

- 1 **Esgotamento:** A cuidadora chegou ao limite humano e emocional.
- 2 **Critério perigoso:** O cansaço explica a crise, mas não decide o valor da pessoa cuidada.
- 3 **Resposta prudente:** É preciso pedir ajuda, revezar tarefas e buscar suporte de saúde e família.

CONFERÊNCIA

Como separar a necessidade urgente de ajuda do erro de usar o cansaço como medida do valor da vida?

NOTA

Não culpe quem está esgotado; mostre que esgotamento precisa de suporte, não de morte.

I10 - G15

N15

Escolha sem ferida

NARRATIVAS FALSAS

CASO

Um site descreve a eutanásia como decisão privada, tranquila e sem impacto em ninguém além do paciente.

LEITURA DO CASO

- 1 **Privatização:** A decisão é apresentada como se não envolvesse médicos, família e sociedade.
- 2 **Ferida objetiva:** A morte provocada compromete quem pede, quem executa e quem normaliza.
- 3 **Bem comum:** Quando matar vira serviço, todos os vulneráveis ficam menos protegidos.

CONFERÊNCIA

Quais feridas morais e sociais ficam escondidas quando a eutanásia é tratada como escolha isolada?

NOTA

Mostre que atos contra a vida nunca ficam isolados no indivíduo.

B08 - I11

G01

Matar ou permitir morrer

DISCERNIMENTOS

CASO

Dois pacientes terminais deixam de receber tratamentos agressivos; em um caso a equipe mantém conforto, no outro aplica uma substância para causar a morte.

LEITURA DO CASO

- 1 **Casos parecidos:** Ambos envolvem fim de vida e interrupção de agressividade terapêutica.
- 2 **Ato diferente:** Em um caso aceita-se a morte inevitável; no outro, causa-se a morte.
- 3 **Critério moral:** A Igreja permite recusar obstinação, mas exclui a eutanásia direta.

CONFERÊNCIA

Que diferença moral separa permitir morrer de matar diretamente?

NOTA

A comparação deve deixar claro que o resultado biológico não basta para julgar o ato.

CEC 2277 - CEC 2278

G02

Intenção ou efeito

DISCERNIMENTOS

CASO

Um analgésico forte pode reduzir a consciência e talvez abreviar a vida; a equipe o usa para controlar dor, não para matar.

LEITURA DO CASO

- 1 **Efeito previsto:** A medicação pode trazer riscos junto com o alívio.
- 2 **Intenção correta:** O objetivo é aliviar sofrimento, não produzir morte.
- 3 **Proporção:** Quando o risco é tolerado e inevitável, o cuidado pode ser moralmente lícito.

CONFERÊNCIA

Como a intenção e a proporcionalidade ajudam a julgar esse caso?

NOTA

Explique o efeito previsto e tolerado sem usar jargão técnico demais.

CEC 2279 - B09

G03

Dor ou desespero

DISCERNIMENTOS

CASO

Um paciente com sintomas controlados insiste que quer morrer porque se sente sozinho, inútil e com medo do que virá.

LEITURA DO CASO

- 1 **Sufrimento complexo:** A dor física não é o único motivo do pedido.
- 2 **Resposta inadequada:** Tratar desespero com morte provocada abandona a pessoa no ponto mais frágil.
- 3 **Cuidado integral:** É preciso escuta, presença, saúde mental, apoio espiritual e vínculo.

CONFERÊNCIA

Por que é importante distinguir dor física de desespero antes de responder ao pedido de morte?

NOTA

Mostre que sofrimento humano é amplo e pede respostas diferentes.

I02 - O05

G04

Ordinário ou extraordinário

DISCERNIMENTOS

CASO

A família pergunta se retirar uma máquina experimental caríssima é o mesmo que parar água, higiene e controle de dor.

LEITURA DO CASO

- 1 **Dúvida legítima:** A família mistura realidades muito diferentes sob a palavra retirar.
- 2 **Diferença moral:** Cuidados comuns são devidos; tratamentos extraordinários podem ser recusados se desproporcionais.
- 3 **Avaliação prudente:** A decisão deve considerar benefício, risco, ônus e intenção.

CONFERÊNCIA

Que critérios ajudam a separar cuidado ordinário de tratamento extraordinário?

NOTA

Evite responder só com sim ou não; trabalhe tipo de cuidado, benefício e proporção.

CEC 2278 - CEC 2279

G05

Proporcionado ou fútil

DISCERNIMENTOS

CASO

Um procedimento arriscado pode acrescentar poucos dias de inconsciência ao paciente, com dor e deslocamentos, sem chance de melhora.

LEITURA DO CASO

- 1 **Ganho frágil:** O procedimento oferece tempo biológico sem melhora real.
- 2 **Ônus pesado:** Risco, dor e deslocamento podem superar o benefício esperado.
- 3 **Prudência:** Recusar futilidade pode respeitar a dignidade do paciente.

CONFERÊNCIA

Quando um recurso médico deixa de ser cuidado proporcionado e se torna futilidade?

NOTA

Mostre que prolongar tempo não é automaticamente servir à pessoa.

CEC 2278 - 103

G06

Sedação ou eutanásia

DISCERNIMENTOS

CASO

Duas prescrições parecem semelhantes: uma reduz consciência para aliviar falta de ar extrema; outra usa dose letal para que o paciente morra.

LEITURA DO CASO

- 1 **Semelhança externa:** As duas cenas envolvem medicação no fim da vida.
- 2 **Finalidade distinta:** Uma busca alívio proporcionado; a outra busca causar morte.
- 3 **Juízo moral:** O cuidado paliativo é encorajado; a eutanásia direta é excluída.

CONFERÊNCIA

Que perguntas devem ser feitas para distinguir sedação de eutanásia?

NOTA

Peça que a equipe identifique intenção, dose, finalidade e proporção.

CEC 2279 - 105

G07

Cuidado ou obstinação

DISCERNIMENTOS

CASO

A equipe propõe parar intervenções invasivas, mas continuar analgesia, higiene, presença e comunicação com a família.

LEITURA DO CASO

- 1 **Técnica interrompida:** As intervenções invasivas já não trazem benefício proporcional.
- 2 **Cuidado mantido:** O paciente continua recebendo alívio, higiene e presença.
- 3 **Critério cristão:** A rejeição da obstinação aceita limites da medicina sem provocar morte.

CONFERÊNCIA

Como esse caso mostra que recusar obstinação não significa abandonar o doente?

NOTA

Mostre o equilíbrio entre não insistir em técnica inútil e não abandonar cuidados.

CEC 2278 - 104

G08

Pessoa ou condição

DISCERNIMENTOS

CASO

No relatório, um paciente é descrito apenas como terminal do leito 12, e ninguém usa seu nome durante a passagem de plantão.

LEITURA DO CASO

- 1 **Redução clínica:** A pessoa é identificada somente por estado e leito.
- 2 **Condição não é pessoa:** Terminalidade descreve uma situação médica, não o valor do paciente.
- 3 **Cuidado humanizado:** Decidir bem exige ver alguém concreto, não apenas um caso.

CONFERÊNCIA

Por que nomear a pessoa muda a maneira de decidir sobre sua condição clínica?

NOTA

Use o exemplo da linguagem para mostrar uma distinção moral profunda.

B06 - CEC 2276

G09

Autonomia ou abandono

DISCERNIMENTOS

CASO

Um hospital entrega ao paciente um formulário sobre morte assistida, mas não oferece paliativos, psicólogo, assistência social ou visita familiar.

LEITURA DO CASO

- 1 **Opção estreita:** O paciente recebe a possibilidade de morrer, mas não alternativas de cuidado.
- 2 **Autonomia ferida:** Uma decisão sem suporte pode nascer de abandono, não de liberdade.
- 3 **Vontade razoável:** Respeitar o paciente inclui oferecer condições reais de cuidado proporcional.

CONFERÊNCIA

Quando a linguagem da autonomia pode esconder abandono institucional?

NOTA

Mostre que escolha sem cuidado real pode ser pressão disfarçada.

CEC 2278 - 107

G10

Culpa ou responsabilidade

DISCERNIMENTOS

CASO

Uma filha, mal orientada e em pânico, autorizou algo que depois descobriu ter sido eutanásia; agora carrega culpa e confusão.

LEITURA DO CASO

- 1 **Ato grave:** A eutanásia direta continua sendo moralmente inadmissível.
- 2 **Responsabilidade concreta:** Medo, ignorância e pressão podem diminuir a culpa subjetiva.
- 3 **Caminho pastoral:** A resposta exige verdade, arrependimento possível, acompanhamento e misericórdia.

CONFERÊNCIA

Como condenar o ato objetivamente errado sem esmagar uma pessoa que agiu sob medo e ignorância?

NOTA

Uma verdade moral e misericórdia pastoral.

CEC 1735 - CEC 2277

G11

Desejo ou pedido

DISCERNIMENTOS

CASO

Depois de uma noite de dor e solidão, um paciente diz quero morrer; na manhã seguinte, depois de ser medicado e ouvido, já não repete a frase.

LEITURA DO CASO

- 1 **Momento crítico:** A frase surge no auge de dor e isolamento.
- 2 **Pedido instável:** O desejo muda quando sofrimento e solidão recebem cuidado.
- 3 **Escuta responsável:** O pedido deve abrir investigação e cuidado, não morte provocada.

CONFERÊNCIA

O que esse caso ensina sobre interpretar um pedido de morte?

NOTA

Mostre que escutar inclui levar a sério sem executar imediatamente.

101 - 005

G12

Consciência ou pressão

DISCERNIMENTOS

CASO

A paciente se sente obrigada a assinar uma decisão porque os filhos falam que não podem mais pagar e o médico parece apressado.

LEITURA DO CASO

- 1 **Pressões somadas:** Dinheiro, pressão e culpa pesam sobre a decisão.
- 2 **Consciência ameaçada:** A pessoa pode assinar para aliviar os outros, não porque discerniu bem.
- 3 **Formação e tempo:** Decisões graves pedem informação, liberdade possível e orientação moral.

CONFERÊNCIA

Que sinais indicam que uma decisão não está nascendo de consciência livre e formada?

NOTA

Mostre pressões familiares, econômicas e médicas sem demonizar todos os envolvidos.

B14 · CEC 1783

G13

Misericórdia ou banalização

DISCERNIMENTOS

CASO

Em uma conversa, alguém diz que a eutanásia deveria ser simples como assinar autorização para um procedimento comum.

LEITURA DO CASO

- 1 **Rotina aparente:** A morte provocada é tratada como procedimento comum.
- 2 **Banalização:** A linguagem simples demais apaga a gravidade moral do ato.
- 3 **Misericórdia verdadeira:** Misericórdia se aproxima do sofredor e cuida dele, não banaliza sua eliminação.

CONFERÊNCIA

Como distinguir misericórdia diante do sofrimento de banalização da morte provocada?

NOTA

Aponte o perigo de normalizar como rotina aquilo que toca a vida inocente.

B10 · N01

G14

Aceitar ou provocar

DISCERNIMENTOS

CASO

Uma família aceita que a doença chegou ao fim e decide não iniciar uma cirurgia inútil; outra pede uma ação para fazer a morte chegar mais cedo.

LEITURA DO CASO

- 1 **Limite aceito:** No primeiro caso, reconhece-se que a medicina não pode impedir a morte.
- 2 **Morte provocada:** No segundo, a morte é buscada como resultado da ação.
- 3 **Discernimento cristão:** Aceitar o limite pode ser prudente; provocar a morte é inadmissível.

CONFERÊNCIA

Que diferença existe entre aceitar a morte inevitável e provocá-la?

NOTA

Use contraste simples, sem tornar a decisão clínica rasa.

CEC 2277 · CEC 2278

G15

Prudência ou omissão

DISCERNIMENTOS

CASO

A equipe decide não transferir o paciente para uma cirurgia sem benefício, mas também esquece de organizar controle de dor e presença familiar.

LEITURA DO CASO

- 1 **Decisão parcial:** Não operar pode ser prudente diante da falta de benefício.
- 2 **Falha de cuidado:** Sem analgesia e presença, a prudência vira abandono prático.
- 3 **Cuidado integral:** Recusar obstinação exige planejar cuidados devidos até o fim.

CONFERÊNCIA

Quando a recusa de um tratamento desproporcional vira omissão de cuidados devidos?

NOTA

Mostre que uma decisão correta pode ser mal conduzida se abandona o cuidado.

CEC 1806 · CEC 2279

O01

Controlar a dor

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Ao perceber que a medicação não basta, a família anota horários, intensidade da dor e efeitos, e pede revisão médica no mesmo dia.

LEITURA DO CASO

- 1 **Observação concreta:** A família reúne informações úteis em vez de apenas se desesperar.
- 2 **Pedido legítimo:** Revisar analgesia é parte do cuidado devido ao doente.
- 3 **Alternativa à morte:** Aliviar sofrimento enfraquece a falsa ideia de que matar é solução.

CONFERÊNCIA

Por que controlar a dor é uma resposta moral concreta contra a lógica da eutanásia?

NOTA

Mostre ação prática e proporcional, sem transformar familiares em médicos.

CEC 2279 · I02

O02

Buscar paliativos

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Depois de várias internações sem cura possível, a família pede encaminhamento para uma equipe de cuidados paliativos em vez de continuar decisões improvisadas.

LEITURA DO CASO

- 1 **Mudança de foco:** A família deixa de buscar cura impossível e procura cuidado adequado.
- 2 **Cuidado ativo:** Paliativos tratam dor, sintomas, angústias e necessidades familiares.
- 3 **Caridade:** A Igreja os encoraja como forma privilegiada de caridade desinteressada.

CONFERÊNCIA

Como os cuidados paliativos respondem ao sofrimento sem desejar a morte?

NOTA

Explique paliativos como cuidado ativo, não desistência.

CEC 2279 · B10

O03

Recusar obstinação

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Com orientação médica clara, o paciente decide não iniciar um tratamento experimental agressivo que traria grande sofrimento e quase nenhum benefício.

LEITURA DO CASO

- 1 **Tratamento pesado:** O recurso é agressivo e sem expectativa razoável de benefício.
- 2 **Recusa legítima:** O Catecismo permite rejeitar procedimentos extraordinários ou desproporcionais.
- 3 **Sem intenção de matar:** A decisão aceita não poder impedir a morte e mantém cuidados devidos.

CONFERÊNCIA

Por que essa recusa pode ser moralmente lícita sem ser eutanásia?

NOTA

Reforce que não se quer a morte; aceita-se a limitação do tratamento.

CEC 2278 · G07

O04

Manter cuidados devidos

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Mesmo sem novas terapias curativas, a equipe mantém higiene, hidratação possível, mudança de posição, curativos e controle de desconforto.

LEITURA DO CASO

- 1 **Sem cura:** A medicina já não oferece tratamento curativo eficaz.
- 2 **Cuidado continua:** Higiene, conforto e alívio seguem moralmente devidos.
- 3 **Dignidade preservada:** A pessoa deve ser cuidada como pessoa até a morte natural.

CONFERÊNCIA

Por que manter cuidados devidos é parte essencial de respeitar a vida até o fim?

NOTA

Mostre que o fim de terapias curativas não é fim do cuidado.

CEC 2279 · B12

005

Escutar sem matar

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Quando o paciente pede para morrer, a enfermeira chama a equipe, pergunta sobre dor, medo e solidão, e comunica a família para reforçar presença.

LEITURA DO CASO

- 1 **Pedido levado a sério:** A enfermeira não ignora a frase nem a trata como escândalo.
- 2 **Investigação:** Ela procura causas concretas: dor, medo, solidão e abandono.
- 3 **Resposta correta:** O pedido vira caminho de cuidado, não autorização para matar.

CONFERÊNCIA

Como escutar seriamente um pedido de morte sem aceitar a morte provocada como resposta?

NOTA

Destaque que escutar não é concordar com tudo; é cuidar da pessoa inteira.

I01 - G11

006

Decidir em conjunto

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Antes de suspender um procedimento desproporcional, a equipe conversa com o paciente capaz, explica riscos e chama a família para alinhar os cuidados.

LEITURA DO CASO

- 1 **Informação compartilhada:** O paciente recebe explicação sobre riscos, benefícios e limites.
- 2 **Responsabilidade ordenada:** A família participa sem substituir indevidamente a pessoa capaz.
- 3 **Prudência moral:** Decidir em conjunto reduz pressão, erro e abandono.

CONFERÊNCIA

Por que decisões de fim de vida exigem diálogo responsável e não ato isolado de uma pessoa apressada?

NOTA

Aponte o valor da vontade razoável do paciente e dos interesses legítimos.

CEC 2278 - B14

007

Pedir segunda opinião

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Diante de divergência entre médicos sobre retirar um suporte, a família solicita avaliação de outro especialista e da equipe paliativa.

LEITURA DO CASO

- 1 **Dúvida grave:** Há divergência real sobre proporcionalidade e benefício.
- 2 **Busca de clareza:** Outra avaliação pode reduzir erro, pressão e decisão precipitada.
- 3 **Limite:** Depois de esclarecida a situação, a família deve decidir com responsabilidade.

CONFERÊNCIA

Quando pedir segunda opinião é prudência, e não fuga da decisão?

NOTA

Mostre que prudência busca clareza; não é adiamento infinito.

CEC 1806 - G05

008

Proteger o vulnerável

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Uma assistente social percebe que uma paciente idosa concorda com tudo olhando para o filho, que responde por ela e controla seus documentos.

LEITURA DO CASO

- 1 **Sinal de controle:** A paciente parece depender da aprovação do filho para falar.
- 2 **Vulnerabilidade:** Idade, doença e dependência podem facilitar pressão e abuso.
- 3 **Proteção prática:** É preciso ouvir a paciente com segurança e acionar responsáveis competentes se houver risco.

CONFERÊNCIA

Que medidas protegem a liberdade e a dignidade de alguém vulnerável nesse caso?

NOTA

Fale de proteção concreta sem sugerir confronto imprudente.

CEC 2276 - B07

009

Acompanhar a família

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Uma irmã percebe que a cuidadora principal está exausta e organiza revezamento semanal, contato com serviço de saúde e uma conversa franca sobre limites.

LEITURA DO CASO

- 1 **Esgotamento visto:** A cuidadora principal não é tratada como culpada, mas como alguém no limite.
- 2 **Apoio concreto:** Revezamento e orientação reduzem decisões movidas por desespero.
- 3 **Proteção do doente:** Quando a família é sustentada, o cuidado fica mais justo e perseverante.

CONFERÊNCIA

Como apoiar cuidadores ajuda a proteger o doente de decisões injustas?

NOTA

Mostre que cuidar do cuidador também é defesa da vida.

I10 - N14

010

Chamar assistência espiritual

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Um paciente católico em fase final pede para falar com um padre; a família, com medo da palavra morte, adia o contato.

LEITURA DO CASO

- 1 **Pedido espiritual:** O paciente expressa uma necessidade de fé no fim da vida.
- 2 **Medo familiar:** A família confunde chamar o padre com admitir derrota.
- 3 **Cuidado integral:** Oração, sacramentos e escuta espiritual sustentam a pessoa diante de Deus.

CONFERÊNCIA

Por que assistência espiritual é cuidado real, e não sinal de desistência?

NOTA

Fale dos sacramentos com respeito e sem reduzir a fé a consolo psicológico.

Tg 5,14-15 - CEC 1520

011

Falar com verdade

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Em uma reunião, todos usam expressões vagas como descanso definitivo e ajuda final; uma médica pede que se diga claramente se estão falando de sedação paliativa ou de provocar a morte.

LEITURA DO CASO

- 1 **Eufemismos:** As palavras vagas escondem o que realmente será feito.
- 2 **Verdade moral:** Não se pode discernir bem quando a linguagem confunde cuidado e morte provocada.
- 3 **Proteção:** Falar com clareza ajuda a evitar erro, pressão e cooperação com o mal.

CONFERÊNCIA

Por que palavras claras são necessárias para decisões morais sérias?

NOTA

Mostre que linguagem precisa protege a consciência e o doente.

B08 - G01

012

Organizar presença

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Como a paciente fica sozinha muitas horas, a família monta uma escala simples de visitas curtas, ligações e ajuda nas refeições.

LEITURA DO CASO

- 1 **Solidão identificada:** A família percebe um vazio real no cuidado cotidiano.
- 2 **Ação possível:** A escala simples transforma boa intenção em presença verificável.
- 3 **Caridade concreta:** Visitar o enfermo exige tempo, organização e fidelidade possível.

CONFERÊNCIA

Por que presença organizada é mais concreta do que apenas dizer que a pessoa não está sozinha?

NOTA

Destaque resposta possível e proporcional, sem idealizar disponibilidade total.

Mt 25,36 - I14

O13

Registrar vontade razoável

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Uma paciente registra que não quer tratamentos fúteis, mas deseja receber cuidados de conforto, presença familiar e assistência espiritual, sem pedido de morte provocada.

LEITURA DO CASO

- 1 **Clareza antecipada:** O documento ajuda a evitar confusão em momento crítico.
- 2 **Vontade razoável:** Recusa de futilidade aparece junto com pedido de cuidados devidos.
- 3 **Limite moral:** O registro exclui a morte provocada e orienta o cuidado proporcional.

CONFERÊNCIA

Como um registro claro pode ajudar sem cair na lógica da eutanásia?

NOTA

Mostre que registrar vontade não significa reivindicar poder de ser morto.

CEC 2278 - I15

O14

Denunciar abandono

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Uma vizinha percebe que um idoso acamado passa dias sem higiene e sem medicação; ela registra fatos e aciona o serviço competente.

LEITURA DO CASO

- 1 **Negligência concreta:** O idoso está sem cuidados básicos e não consegue se proteger.
- 2 **Responsabilidade:** A omissão de terceiros pode ferir gravemente a dignidade do vulnerável.
- 3 **Ação proporcional:** Registrar fatos e acionar responsáveis protege sem expor inutilmente.

CONFERÊNCIA

Como denunciar abandono pode ser uma forma concreta de defender a vida?

NOTA

Ensine prudência: fatos, responsáveis competentes e proteção da pessoa.

B07 - I13

O15

Sustentar profissionais

ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

CASO

Uma enfermeira se recusa a participar de procedimento destinado a causar morte e pede remanejamento, mantendo-se disponível para cuidados paliativos.

LEITURA DO CASO

- 1 **Recusa legítima:** A enfermeira não quer cooperar com a morte provocada.
- 2 **Cuidado mantido:** Ela permanece disponível para aliviar, acompanhar e cuidar.
- 3 **Testemunho profissional:** A consciência formada protege a medicina de virar instrumento de eliminação.

CONFERÊNCIA

Como apoiar profissionais fiéis à consciência ajuda a proteger pacientes vulneráveis?

NOTA

Mostre objeção moral como responsabilidade, não abandono do paciente.

B14 - I11